ONEMA-POP-034 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-034 — Manejo de Náuseas e Vômitos Refratários em
Cuidados Paliativos

1. Identificação institucional

983558 | Data: 09/11/2026.

2. Objetivo e abrangência

Padronizar manejo de náuseas e vômitos refratários em cuidados paliativos na atuação da rede ONEMA ONE, com avaliação, execução segura, continuidade e escalonamento. Aplicável ao atendimento domiciliar e, quando pertinente, digital; não substitui decisões médicas nem suporte de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Execução e julgamento clínico por enfermeiro habilitado, conforme competências e treinamento. Indicações: Pessoas em
cuidados paliativos com náuseas/vômitos persistentes; exige plano compartilhado e avaliação de causas reversíveis. Contraindicações operacionais: ausência de consentimento ou de condições seguras, urgência incompatível com atendimento eletivo, ou ação fora da competência/prescrição.

4. Materiais, equipamentos e fornecimento

Enfermeiro: materiais de avaliação, recipientes, EPI conforme risco, itens de higiene oral; paciente: prescrições e plano paliativo, materiais de conforto. Em visitas presenciais, o profissional dispõe de aparelho de pressão validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro; utilizar conforme avaliação. Insumos específicos são providenciados pelo paciente/responsável, salvo acordo contratual.

5. Avaliação clínica e preparo

Frequência, volume/aspecto do vômito, hidratação, constipação, distensão, dor, medicamentos, ingestão e objetivos de cuidado. Confirmar identidade, consentimento, privacidade, ambiente e plano prévio; estabelecer linha de base e reconhecer urgências antes de iniciar.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar plano de cuidados, preferências do paciente e prescrições antieméticas vigentes.

2. Quantificar episódios e caracterizar conteúdo, relação com alimentação e medicamentos.

3. Avaliar mucosas, diurese, estado mental, distensão e dor abdominal; investigar constipação e retenção urinária.

4. Identificar sinais de obstrução intestinal, hematêmese, desidratação importante ou aspiração.

5. Oferecer posicionamento seguro, higiene oral, ambiente ventilado e pequenas ofertas de líquidos apenas se deglutição

segura e plano permitir.

6. Administrar antiemético somente se prescrito, conferindo via, alergias, contraindicações e resposta.

7. Se refratário, comunicar equipe paliativa para revisão de causa, via e esquema terapêutico; não modificar por iniciativa

própria.

8. Reavaliar conforto, episódios e aceitação; registrar intervenções, resposta e plano de contato.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Hematêmese, aspiração, distensão importante com dor intensa ou instabilidade: avaliação urgente compatível com objetivos de cuidado e plano antecipado. Em emergência, acionar SAMU 192 e registrar horário e destinatário; não retardar atendimento por registro digital.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar família sobre higiene oral, posicionamento e quando comunicar equipe; não forçar alimentação. Confirmar compreensão por retorno verbal e definir quem será contatado em caso de piora.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa, histórico e avaliação, sinais vitais pertinentes, diagnósticos

e plano de Enfermagem, passos executados e não executados com justificativa, resposta clínica, intercorrências, orientações, contatos e encaminhamentos, profissional responsável e assinatura/trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

 NICE NG31 — Care of dying adults in the last days of life — https://www.nice.org.uk/guidance/ng31/chapter/Recommendations

 OMS — Palliative care, fact sheet — https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

 COFEN, Resolução nº 736/2024 — Processo de Enfermagem — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/